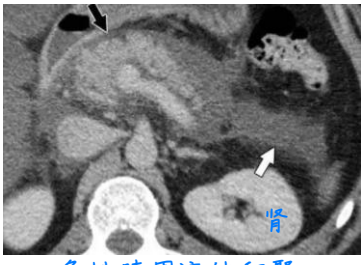
4.胰周积液

- 渗液密度均匀（CT）单纯炎性渗出
  - 急性胰周液体积聚:多不需要引流
  - 假性囊肿（多继发于胰腺炎,少数继发于胰腺外伤、胰腺癌）
    - 纤维组织增生(1个月左右)
    - 缺乏上皮细胞(无分泌功能)
    - 囊内含胰酶,且和严重程度相关
    - 主要表现:上腹部触及包块
    - 体温多正常(若继发感染明显发热)
    - B超或CT:囊性包块、液性暗区/密度
    - >6cm或压迫胃明显等:先保守治疗待6-8周后囊壁成熟行超声引导下内引流(囊肿-空肠R-Y吻合术)

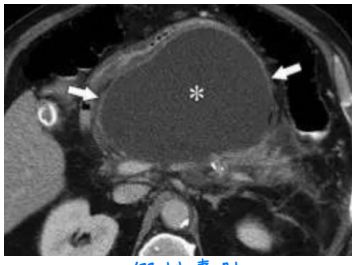
VS 真囊肿:囊壁由上皮细胞构成,有分泌功能

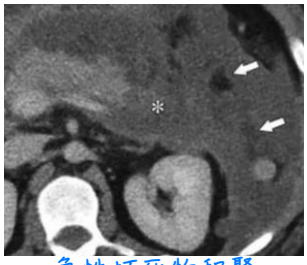
内引流:把囊内胰液引流入消化道
假性囊肿的囊内胰液干净可以继续使用
若假性囊肿继发感染则需要外引流
eg.炎性腹水和癌性腹水不能浓缩回输

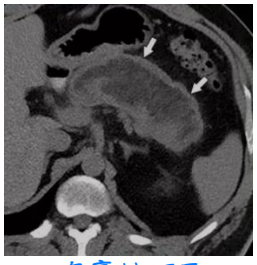
- （CT）渗液密度不均匀（含液体、坏死脂肪、坏死胰腺组织等）
  - 急性坏死物积聚 ANC
  - 包裹性坏死WON:1个月左右



急性胰周液体积聚


假性囊肿


急性坏死物积聚


包裹性坏死

5.**胰腺感染**

（1）胰腺坏死＞30%（重症）感染率明显增加

（2）感染源多来自肠道，如大肠杆菌、铜绿假单胞菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌（打哦啵绿）

体温增高、血白细胞增高不能直接判定为胰腺感染(人财两空)
- 坏死物吸收热
- 应激时白细胞也高

（3）感染通常发生在重症胰腺炎发作 2 周左右，表现为：

①**体温＞38.5 度**

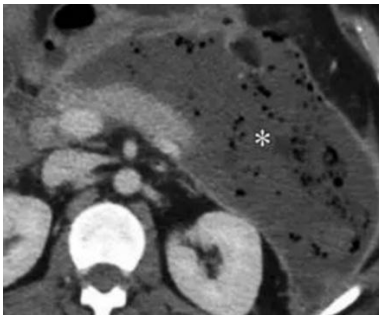
②**血白细胞＞16×10⁹/L**（3+8+5=16）

③腹膜刺激征范围超过腹部两个象限

④腰部明显压痛、ttsx 丰满、发红、水肿（腹膜后间隙感染）

⑤CT 示 ANC 或 WON 内气泡征 细菌产气

⑥病程长者营养不良


边缘池
循环池

减少肠道细菌

（4）预防胰腺感染：①硫酸钠或乳果糖导泻；②口服左氧氟沙星+甲硝唑等抗生素；③尽早恢复肠内营养（肠道是全身炎症反应的策源地）；④若胰腺坏死＞30%可预防性静注碳青霉烯类（培南）

禁食期用肠外营养,但不能一直给肠外营养,因为会导致肠粘膜屏障废用性萎缩,更易促使肠道细菌毒素移位

（5）并发胰腺感染时：

针对G-杆菌和厌氧菌

①**抗生素降阶梯**治疗：**碳青霉烯类（培南）、三代头孢或喹诺酮类+甲硝唑**，疗程 7-14 天

②**坏死组织清除和外引流术**（穿刺等）

坏死组织易引发感染